

Psicofarmacología básica (ISRS, antipsicóticos, estabilizadores, ansiolíticos)

1. Introducción y relevancia clínica

La **psicofarmacología** es la disciplina que estudia los efectos de los medicamentos sobre la conducta, las emociones y el pensamiento.

Su objetivo es **restaurar el equilibrio neuroquímico** alterado en los trastornos psiquiátricos, mejorando los síntomas y la funcionalidad del paciente.

En Chile, los **fármacos psicotrópicos** se prescriben ampliamente en **APS y especialidad**, siendo los más utilizados:

- **ISRS (inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina)** → primera línea en depresión y ansiedad.
- **Antipsicóticos** → esquizofrenia, psicosis, trastorno bipolar.
- **Estabilizadores del ánimo** → bipolaridad y prevención de recaídas.
- **Ansiolíticos (benzodiacepinas)** → control sintomático a corto plazo.

□ En el **EUNACOM**, se evalúan mecanismos de acción, efectos adversos graves (como el síndrome neuroléptico maligno o la hiponatremia por ISRS) y decisiones clínicas básicas (elección del fármaco según paciente y comorbilidades).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Principio general

Los psicofármacos actúan modulando los **neurotransmisores cerebrales** implicados en la regulación del ánimo, la cognición y la conducta.

Los sistemas más relevantes son:

Neurotransmisor	Función principal	Relación con patologías
-----------------	-------------------	-------------------------

Serotonina (5-HT)	Estado de ánimo, ansiedad, sueño	↓ en depresión y ansiedad
Dopamina (DA)	Motivación, placer, movimiento	↑ en psicosis / ↓ en parkinsonismo y depresión
Noradrenalina (NA)	Alerta, energía, atención	↓ en depresión
GABA	Inhibición neuronal	↓ en ansiedad
Glutamato	Excitación neuronal	↑ tóxico en esquizofrenia y epilepsia

Los fármacos buscan **restaurar el balance** de estos sistemas. Por ejemplo:

- ISRS aumentan serotonina.
- Antipsicóticos bloquean receptores dopaminérgicos D₂.
- Estabilizadores del ánimo regulan la señal intracelular (litio).
- Benzodiacepinas potencian GABA.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

Los psicofármacos no “curan” los trastornos mentales, sino que **controlan los síntomas**, reducen recaídas y permiten que el paciente participe activamente en psicoterapia y rehabilitación.

El **diagnóstico preciso** (según CIE-10/DSM-5) orienta la elección farmacológica:

Trastorno

Tratamiento farmacológico de elección

Depresión mayor	ISRS (sertralina, fluoxetina, escitalopram)
Trastorno de ansiedad generalizada	ISRS o venlafaxina (no benzodiacepinas a largo plazo)
Esquizofrenia	Antipsicóticos atípicos (risperidona, olanzapina, quetiapina)
Trastorno bipolar	Litio o valproato como estabilizadores del ánimo
Insomnio, crisis de pánico aguda	Benzodiacepinas de corta duración

- ☐ Diagnóstico diferencial esencial: síntomas depresivos o ansiosos secundarios a causas médicas (hipotiroidismo, anemia, abstinencia, tumores).

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Antes de iniciar tratamiento psicofarmacológico, deben realizarse **exámenes de base** según el tipo de fármaco y el perfil del paciente:

Grupo farmacológico	Exámenes recomendados antes de iniciar
ISRS / IRSN	Función hepática y sodio (riesgo de hiponatremia)
Antipsicóticos	Glucosa, perfil lipídico, IMC, EKG (QT prolongado)
Litio	Creatinina, electrolitos, TSH, EKG
Valproato	Transaminasas, amilasa, hemograma

Carbamazepina Hemograma, función hepática

Benzodiacepinas Evitar en EPOC, SAHOS, alcoholismo

Criterios de respuesta terapéutica

- **Depresión:** mejoría $\geq 50\%$ en síntomas tras 6–8 semanas.
 - **Psicosis:** reducción de alucinaciones y mejora funcional en 4–6 semanas.
 - **Bipolaridad:** estabilización del ánimo y prevención de episodios durante 6 meses.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

Las **guías clínicas MINSAL (2023–2024)** establecen protocolos estandarizados para el manejo de los principales trastornos psiquiátricos.

A continuación, se resumen los grupos de psicofármacos más relevantes.

5.1. ISRS (Inhibidores Selectivos de la Recaptura de Serotonina)

Ejemplos: Fluoxetina, sertralina, escitalopram, paroxetina, citalopram.

Mecanismo: Bloquean la recaptura presináptica de serotonina, aumentando su disponibilidad sin alterar otros neurotransmisores.

Indicaciones:

- Depresión mayor (GES MINSAL).
- Trastorno de ansiedad generalizada.
- Trastorno obsesivo-compulsivo.
- Estrés postraumático.
- Trastorno de pánico.

Efectos adversos:

- Náuseas, cefalea, insomnio o somnolencia.
- Disfunción sexual (muy frecuente).
- **Hiponatremia** (en adultos mayores).
- Riesgo de **síndrome serotoninérgico** (si se combina con otros serotoninérgicos).

Ventajas:

- Alta seguridad en sobredosis.
- Bien tolerados.
- Eficaces también en ansiedad.

□ **Primera elección en APS según Guía MINSAL de Depresión 2023:**
Sertralina 50 mg/día o Fluoxetina 20 mg/día (ajustable).

5.2. Antipsicóticos

División:

- **Típicos (1ª generación):** haloperidol, clorpromazina.
- **Atípicos (2ª generación):** risperidona, olanzapina, quetiapina, clozapina, aripiprazol.

Mecanismo:

- Bloqueo de receptores D₂ (dopamina).
- Los atípicos también modulan serotonina (5-HT_{2A}), reduciendo efectos extrapiramidales.

Indicaciones:

- Esquizofrenia (GES).
- Trastorno esquizoafectivo.
- Trastorno bipolar (episodio maníaco).

- Psicosis inducida por sustancias.

Efectos adversos:

Tipo	Ejemplo	Prevención / manejo
Extrapiramidales	Rigidez, distonías, acatisia	Biperideno, cambio de fármaco
Síndrome neuroléptico maligno	Fiebre, rigidez, ↑ CPK, confusión	Suspender fármaco, ICU, dantroleno
Metabólicos (atípicos)	↑ peso, resistencia insulina, dislipidemia	Control IMC, glicemia, dieta
Cardíacos	Prolongación QT	EKG basal y control

□ **Clozapina:** indicada en esquizofrenia resistente; riesgo de agranulocitosis → control hematológico semanal los primeros 6 meses.

5.3. Estabilizadores del ánimo

a) Litio

Mecanismo: modula la señal del inositol y la neurotransmisión dopaminérgica y serotoninérgica.

Indicaciones:

- Trastorno bipolar (prevención de manía y depresión).
- Potenciador en depresión resistente.

Efectos adversos:

- Tremor fino, poliuria, hipotiroidismo, nefrotoxicidad.

- Intoxicación por litio: vómitos, confusión, convulsiones → urgencia médica.

Control: litemia cada 3 meses (rango terapéutico 0,6–1,2 mEq/L).

b) Valproato de sodio

Mecanismo: aumenta GABA y bloquea canales de sodio.

Indicaciones: episodio maníaco, prevención bipolar, epilepsia.

Efectos adversos:

- Aumento de peso, náuseas, hepatotoxicidad, trombocitopenia, teratogenicidad (espina bífida).

c) Carbamazepina

Mecanismo: estabiliza membrana neuronal bloqueando canales de sodio.

Indicaciones: bipolaridad tipo II, neuralgia del trigémino.

Efectos adversos: leucopenia, hiponatremia, hepatotoxicidad.

Interacciones: induce enzimas hepáticas → reduce niveles de otros fármacos.

5.4. Ansiolíticos (Benzodiacepinas y otros)

Ejemplos:

- De acción corta: alprazolam, lorazepam.
- De acción larga: diazepam, clonazepam.

Mecanismo:

Potencian la acción de **GABA-A**, principal neurotransmisor inhibitor del SNC → efecto ansiolítico, sedante, anticonvulsivante y relajante.

Indicaciones:

- Crisis de pánico.
- Insomnio transitorio.

- Síndrome de abstinencia alcohólica.
- Catatonia.

Efectos adversos:

- Somnolencia, caídas, dependencia y tolerancia.
- Síndrome de abstinencia si suspensión brusca.
- Depresión respiratoria en sobredosis o combinación con alcohol.

□ **Uso máximo recomendado en APS: 4–6 semanas.**

En EUNACOM, la respuesta correcta suele ser *“usar ISRS como tratamiento de fondo y benzodiacepinas sólo como apoyo inicial”*.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones principales

- Reacciones adversas graves (síndrome neuroléptico maligno, toxicidad por litio).
- Interacciones medicamentosas (ISRS + IMAO → síndrome serotoninérgico).
- Abandono del tratamiento por efectos secundarios.
- Dependencia a benzodiacepinas.

Pronóstico

- El pronóstico mejora con **adhesión terapéutica, monitoreo regular y psicoeducación**.
- Los programas de salud mental del MINSAL enfatizan el **uso racional y seguro de psicofármacos** junto a **intervenciones psicosociales**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□

Perlas clínicas

1. **ISRS = primera línea** para depresión y ansiedad (seguros y bien tolerados).
 2. **Clozapina** es el antipsicótico más eficaz, pero requiere vigilancia hematológica.
 3. **Litio** es el estabilizador clásico; requiere control de niveles plasmáticos.
 4. **Benzodiacepinas** solo a corto plazo, nunca en monoterapia prolongada.
 5. **Valproato** contraindicado en embarazo.
 6. **Antipsicóticos atípicos** → riesgo metabólico (control IMC y glicemia).
 7. En síndrome serotoninérgico: confusión, fiebre, hiperreflexia, mioclonías → suspender fármacos.
-



Errores comunes

- Combinar ISRS con IMAO o triptanos (riesgo serotoninérgico).
 - Usar benzodiacepinas crónicamente.
 - No monitorizar litemia ni función renal en pacientes con litio.
 - No considerar embarazo o lactancia antes de prescribir.
 - Retirar bruscamente psicofármacos → riesgo de abstinencia y recaída.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Los **ISRS** son la **primera elección** en depresión y ansiedad por su seguridad y eficacia.
2. Los **antipsicóticos atípicos** son preferidos por menor riesgo extrapiramidal, pero requieren control metabólico.

3. El **litio** es el estabilizador más eficaz en bipolaridad, pero con ventana terapéutica estrecha.
4. Las **benzodiacepinas** deben usarse solo a corto plazo para crisis o insomnio.
5. Todo tratamiento requiere **evaluación integral y seguimiento clínico regular**.
6. Las **guías MINSAL 2023** enfatizan el uso racional, combinando fármacos con psicoterapia.
7. Conocer los **efectos adversos graves** es crucial para el manejo seguro y el éxito en EUNACOM.